

Sínteses Integrativa #01

Relação Médico Paciente (R.M.P.)

Érik Luis Mendonça Botechia de Jesus Leite¹

¹Aluno de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

I. Relação Médico-Paciente e Modelos da Relação Médico-Paciente:

Como definição se explicita na bibliografia 1 que a "relação médico-paciente se dá através da interação entre as duas partes 2, que ocorre naturalmente por meio de uma interação comunicativa entre seus participantes, quando se trata de duas pessoas racionais e dotadas de linguagem. Mesmo quando não for este o caso, haverá sempre uma figura intermediária – como um cuidador - que poderá estabelecer esta relação comunicativa."

Para que esta relação se estabeleça é necessário apoiar-se no papel das figuras que envolvem a relação médico-paciente, estas são propostas em alguns modelos descritos em 1972 pelo professor Roberto Veatch e consistem inicialmente no Modelo Sacerdotal, Modelo do Engenheiro, Modelo Colegial e Modelo Contratualista, estes são descritos a seguir de forma contextualizada a elementos da atualidade.

O modelo mais tradicional e baseado na tradição e fundamentos hipocráticos se denomina Modelo Sacerdotal, onde o médico assume uma figura Paternalista que assume a relação de poder e autoridade atuando em prol dos princípios da beneficência e não-maleficência, deste modo o médico assume a capacidade e decisão da melhor escolha para o paciente, atuando assim de maneira ativa por outro lado a figura do paciente assume atitude passiva de mero expectador e subordinada as decisões tomadas pelo médico assume o tratamento como o correto e estabelece um vínculo de gratidão ao médico pelo seu curar.

O modelo do Engenheiro a figura do médico assume um role tecnicista e imparcial, ao qual tem a dominância do conhecimento técnico, pelo qual é responsável pelo raciocínio clínico com a formação de hipóteses diagnosticas, baseadas estritamente em dados coletados de forma técnica e a partir do processamento de estas sem levar em conta o contexto global do paciente elabora o processo de raciocínio clínico e informa ao paciente as possibilidades de tratamento disponíveis para o mesmo, ainda que haja esta retenção de poder em relação ao técnico o paciente tem a liberdade de atuar de forma ativa na tomada de decisão do seu tratamento, onde a partir da elaboração das hipóteses de tratamento assume a figura ativa de escolha e assume a responsabilidade por essa decisão, é importante ressaltar a importância da correta comunicação para que o consentimento do paciente seja de forma informada e entendida nestes casos, uma vantagem deste modelo é a adesão de ferramentas tecnológicas na melhoria do atendimento médico, como conclusão se resume esta

relação como um vínculo de prestação de serviços entre figura médica (prestador de serviço de saúde) e paciente (consumidor do serviço de saúde prestado), sendo assim um modelo onde o médico preserva a autoridade e abre mão do poder em prol da decisão do paciente.

O Modelo Colegial não diferencia as figuras de médico e paciente no estabelecimento do contexto de sua relação, pelo que o processo de tomada de decisão tem o poder compartilhado entre ambos, sendo construído de forma colaborativa, atuando ambas as figuras de forma ativa onde a autoridade do médico está associada à sua figura como profissional, seu conhecimento técnico, suas obrigações e deveres e o paciente como pessoa singular que passa pela experiência de adoecer e busca o tratamento para o retorno de estado de saúde integral, cabe ressaltar que este modelo falha em situações onde os roles estabelecidos e postos em prática mediante o respeito da hierarquização de papéis atuantes se perde, desta maneira quando ocorre essa perda o modelo se torna um tipo de relação inviável para o contexto da relação médico-paciente.

O Modelo Contratualista é de participação ativa pelas figuras da relação médico-paciente, cabe ressaltar que como ponto diferencial de este se estabelece um combinado ou contrato onde ambas as partes estão dispostas a atuar em prol do reestabelecimento do estado de saúde do paciente, pelo que cada um em seu role hierárquico, sendo a figura médica detentora do conhecimento técnico e a figura do paciente aquele que passa pela experiência de adoecer e está disposto a seguir as orientações para recuperar seu estado de saúde por meio dos combinados estabelecidos em plano terapêutico individual (PTI) proposto deste modo se propõe a troca de informações em formato efetivo que fornece as bases para a elaboração do processo de raciocínio clínico da figura médica e estabelecimento das opções terapêuticas disponíveis para a escolha compartilhada do paciente baixo ao consentimento informado e entendido do paciente.

Entre os modelos propostos o mais próximo a realidade atual das relações médico-paciente e baseadas na recuperação da saúde como bem-estar do indivíduo de forma holística biopsicossocial o modelo contratualista se torna a mais vantajosa diante a enfermidades de caráter crônico enquanto um modelo mixto entre modelo do engenheiro e modelo paternalista são mais úteis em casos de urgência e emergência em um terceiro contexto proposto pela reforma psiquiátrica o modelo de colegas se torna efetivo em atendimentos de estadia com duração prolongada como o contexto de comunidades terapêuticas e clínicas de reabilitação que possuem serviços médicos associados o que hoje se denomina modelo de internação residencial com termo de consentimento aclarado e entendido e aceitação voluntária de permanência por parte do paciente.

Com base no parágrafo anterior se estipula que o melhor modelo de relação médico-paciente a ser adotado deve ser induzido por parte do médico com base no contexto aplicado da atuação da figura médica com a finalidade de um atuar harmônico com a situação ao qual o caso necessita, sempre e quando fundamentados nos princípios da bioética, descritos a seguir e que se integram com o conteúdo associado as Softskills Médicas integrados na matriz curricular pela matéria de Desenvolvimento Pessoal, Acadêmico, Profissional e Ético, disponíveis no portfólio de softskills médicas, como compilado de sínteses reflexivas que abordam as temáticas referentes.

Como princípios da bioética moderna, os conceitos a seguir tem como base o relatório de Belmont, estabelecido nos Estados Unidos e que propõe as bases para adequação a ética da pesquisa deste país, os preceitos ali estabelecidos permitem a modernização de conceitos éticos fundamentais da medicina atualizados para o contexto da realidade moderna.

O princípio da Autonomia se traduz neste relatório como Princípio do Respeito as Pessoas que incorpora duas convicções éticas sendo a primeira como que os "indivíduos devem ser tratados como autônomos "e a segunda como que "pessoas com autonomia diminuída devem ser protegidas". Neste contexto divide-se duas exigências morais separadas a de reconhecimento da autonomia e a exigência de proteger aqueles com autonomia reduzida como pessoas com transtornos mentais graves, pessoas em liberdade privada, pessoas com transtornos que lhe dão condições de especiais entre outros.

Pelo último o professor José Roberto Goldim afirma que "todas as teorias concordam que duas condições são essenciais à autonomia" sendo estas "liberdade (independência do controle de influências)" e "ação (capacidade de ação intencional)" desta forma o princípio da autonomia se resume como "autodeterminação de um indivíduo" o que acarreta o surgimento da "responsabilidade pelo respeito da pessoa que talvez seja a melhor denominação para este princípio" desta forma o paciente deve ter uma figura ativa na tomada de decisão do seu tratamento de modo que mediante ao entendimento do exposto e com a autonomia para aceitar o consentimento assistido e compreendido a respeito do seu tratamento.

O segundo descrito é o Princípio da Beneficência que tem duas importantes funções como regra, não causar o mal e maximizar os benefícios possíveis e minimizar os danos possíveis, desta forma o profissional da saúde deve buscar "curar algumas vezes, aliviar muitas vezes, consolar sempre" buscando sempre o viés de menor dano possível quando o bem já não é uma possibilidade.

O terceiro descrito é o Princípio da Privacidade onde se define a "Privacidade é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, ao acesso à própria pessoa, à sua intimidade, envolvendo as questões de anonimato, sigilo, afastamento ou solidão. " desta forma o princípio se sintetiza como " É a liberdade que o paciente tem de não ser observado sem autorização.(4)" de forma complementar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo XII, estabelece que: "Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação" deste modo o sigilo da relação médico paciente, resguardado por lei, permite o manutenção do anonimato de dados e informação daqueles que são cuidados exceto baixo a autorização com assinatura e consentimento informado por parte daquele que a assina."

Este Princípio da Privacidade tem suas reservas já que por força de legislação existente e por justa causa, um profissional é obrigado a comunicar informações a que teve acesso em função de sua atividade. Estes casos são os seguintes: testemunhar em corte judicial, em situações especiais; comunicar, à autoridade competente, a ocorrência de doença de informação compulsória; a ocorrência de maus-tratos em crianças ou adolescentes; de abuso de conjuge ou idoso; ou de ferimento por arma de fogo ou de outro tipo, quando houver suspeita de que tal lesão tenha sido resultante de um ato criminoso pelo que testemunhar em corte judicial, em situações especiais; comunicar, à autoridade competente, a ocorrência de doença de informação compulsória; a ocorrência de maus-tratos em crianças ou adolescentes; de abuso de conjuge ou idoso; ou de ferimento por arma de fogo ou de outro tipo, quando houver suspeita de que tal lesão tenha sido resultante de um ato criminoso.

O princípio bioético de Consentimento Informado já faz parte da obrigação do médico este de acordo com José Roberto Goldim "O consentimento informado é composto por três elementos básicos: competência ou capacidade, informação e consentimento." de forma que "Os quatro elementos necessários para que um consentimento informado seja considerado válido são os seguintes: fornecimento de informações, compreensão, voluntariedade, consentido."

Pelo anterior o Consentimento Informado é caracterizado por um processo de 3 etapas com sete passos incluídos esses são descritos como:

1. Pré-Condições:
 - 1.1. Capacidade (para entender e decidir);
 - 1.2. Voluntariedade (na decisão).
2. Elementos da Informação:
 - 2.1. Explicação (informações sobre riscos e benefícios);
 - 2.2. Recomendação (proposta de alternativa mais adequada);
 - 2.3. Compreensão (dos termos 3 e 4).

3. Elementos do Consentimento:

- 3.1. Decisão (em favor de uma opção, dentre no mínimo duas propostas);
- 3.2. Autorização.

Portanto, na relação médico-paciente é necessário que o consentimento informado seja feito por pessoa capaz, ou pelo seu representante legal, que expresse livremente seu consentimento no tratamento médico necessário.

Com a ciência dos riscos e benefícios e das alternativas de cura e tratamento, o paciente encontra-se apto a externar de forma segura o seu consentimento.

Por fim se finaliza essas sínteses integrativa composta pelo conceito de relação médico-paciente, modelos de relação médico-paciente e aspectos e princípios bioéticos importantes na temática do eixo de Competências Médicas e Pessoais, da unidade de conteúdo denominada Habilidades Procedurais.

BIBLIOGRAFIA:

1. CAMPOS, Carlos Frederico Confort; FÍGARO, Roseli. A Relação Médico-Paciente vista sob o Olhar da Comunicação e Trabalho. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, v. 16, n. 43, p. 2352, 2021. Disponível em: [https://doi.org/10.5712/rbmfc16\(43\)2352](https://doi.org/10.5712/rbmfc16(43)2352). Acesso em: 2 maio 2026.
2. IDISA. **Relação médico-paciente**. Campinas: IDISA, [s.d.]. Disponível em: <https://idisa.org.br/img/File/RelacaoMedicopaciente.pdf>. Acesso em: 2 maio 2026.
3. SALVAGNI, Julice. **O mundo do trabalho na era digital: plataformas, algoritmos e subjetividades**. 2023. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/268213>. Acesso em: 2 maio 2024.
4. REZENDE, Joffre M. de. **Curar algumas vezes, aliviar muitas vezes, consolar sempre**. [S. l.: s. n.], [20--?]. Disponível em: <https://www.medicinacomplementar.com.br/biblioteca/pdfs/Doencas/do-0175.pdf>. Acesso em: 2 maio 2026.